Atención intersectorial y restablecimiento de derechos

Breve descripción:

Este componente formativo aborda la articulación intersectorial necesaria para el restablecimiento de los derechos de las personas víctimas de violencias sexuales, mediante la activación de rutas de atención, la coordinación entre los sectores de salud, protección y justicia, y la aplicación de procedimientos establecidos para la protección integral, el seguimiento y el cierre del caso.

Marzo 2026

Tabla de contenido

Introducción 4

1. Atención clínica inicial en violencias sexuales 6

1.1. Acciones prioritarias iniciales 6

1.2. Consentimiento informado 9

1.3. Registro clínico y decisiones asistenciales 10

2. Profilaxis y prevención en salud 12

2.1. Profilaxis posexposición 12

2.2. Criterios de indicación y oportunidad 16

2.3. Seguimiento clínico 19

3. Anticoncepción de emergencia e IVE 21

4. Atención en salud mental 28

5. Continuidad y seguimiento 32

6. Registro y vigilancia 35

7. Articulación forense 39

8. Activación de rutas 43

9. Acceso a la justicia 47

10. Procedimientos de protección según el contexto 53

11. Programas institucionales de protección 55

11.1. Tipos de programas institucionales 55

11.2. Trámite especial de emergencia 59

12. Restablecimiento de derechos y seguimiento 61

12.1. Autoridades competentes 62

12.2. Seguimiento intersectorial 63

Síntesis 66

Glosario 67

Referencias bibliográficas 69

Créditos 70

Introducción

La atención integral en salud a víctimas de violencias sexuales exige una respuesta oportuna, técnica y articulada. En Colombia, estos casos se consideran una urgencia en salud, lo que implica garantizar atención inmediata, integral y sin barreras administrativas, conforme a la normativa vigente. Este apartado orienta la comprensión de los lineamientos clínicos y administrativos que sustentan la actuación del sector salud, incluyendo la profilaxis, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los casos permitidos por la ley, el registro clínico y la notificación obligatoria en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Asimismo, permite reconocer la importancia de la articulación intersectorial como eje del restablecimiento de derechos y la prevención de la revictimización.

Para ampliar esta visión general y contextualizar los ejes centrales del tema, se invita acceder al siguiente recurso audiovisual introductorio.

Video 1. Atención intersectorial y restablecimiento de derechos

Enlace de reproducción del video

Transcripción del video: Atención intersectorial y restablecimiento de derechos
La atención integral en salud frente a las violencias sexuales requiere un trabajo coordinado entre el sector sanitario, justicia y protección. No se limita a la atención médica inmediata. También incluye la activación de rutas de atención, el registro adecuado de la información y el seguimiento intersectorial para garantizar el restablecimiento de derechos. Cada acción realizada hace parte de una respuesta organizada que busca proteger la vida, la dignidad y la seguridad de la persona afectada. La importancia de este tema radica en fortalecer su desempeño como el talento humano en la salud. Al comprender las responsabilidades técnicas, administrativas y legales, se contribuye a evitar la revictimización, asegurar la continuidad del cuidado y facilitar el acceso a medidas de protección y justicia. Actuar con base en la normatividad vigente permite brindar una atención clara, segura y centrada en la garantía y el restablecimiento pleno de los derechos de las víctimas. Este contenido se abordará desde una perspectiva práctica y normativa, integrando los principales procesos que orientan la atención. Se revisarán las rutas intersectoriales, el registro y la vigilancia en salud pública, la articulación con el ámbito forense y los procedimientos de protección según el contexto. A través de este recorrido, se comprenderá que la actuación del sector salud no se limita a la atención clínica. Hace parte de una respuesta institucional coordinada y se convierte en un eje estratégico para proteger la vida y la dignidad de las personas afectadas.

1. Atención clínica inicial en violencias sexuales

La atención clínica inicial constituye el primer momento operativo de la respuesta del sector salud frente a un caso de violencia sexual y tiene un impacto directo en la protección de la salud integral, la prevención de complicaciones y la garantía de derechos. De acuerdo con la normativa colombiana vigente, toda persona víctima de violencia sexual debe recibir atención inmediata, integral y sin barreras, independientemente del tiempo transcurrido desde el hecho o de la decisión de denunciar, conforme a la Resolución 459 de 2012 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015.

Este momento exige del talento humano una actuación técnica, ética y coordinada, orientada a estabilizar la condición de salud, identificar riesgos prioritarios y activar de manera temprana las acciones clínicas, administrativas e intersectoriales que correspondan, evitando prácticas que puedan generar revictimización institucional.

1.1. Acciones prioritarias iniciales

En coherencia con estos principios, el sector salud debe ejecutar de manera secuencial, articulada y bajo un enfoque de derechos las acciones prioritarias que estructuran la atención inicial. Estas acciones no son aisladas, sino interdependientes, y buscan asegurar el acceso efectivo, la protección de la dignidad y la identificación temprana de riesgos asociados a la violencia sexual.

En coherencia con las acciones prioritarias iniciales descritas, se presentan los principios orientadores que deben garantizarse desde el primer contacto con la persona atendida:

A. Garantizar atención inmediata en salud

- Sin exigir denuncia previa

- Sin barreras administrativas, económicas o institucionales
- Sin discriminación por edad, sexo, identidad de género, orientación sexual o contexto

B. Brindar un entorno seguro y confidencial

- Privacidad durante la atención
- Trato respetuoso, empático y libre de juicios
- Comunicación clara y comprensible

C. Identificar tempranamente situaciones de riesgo

- La situación puede no expresarse de forma directa
- Los motivos de consulta pueden ser físicos, emocionales o inespecíficos
- No se debe forzar el relato de los hechos

Las acciones prioritarias descritas anteriormente sintetizan los principios orientadores de la atención inicial, organizados en tres ejes: garantía de acceso inmediato, ambiente seguro y confidencial, e identificación temprana de posibles situaciones de violencia sexual.

Estas acciones se encuentran alineadas con el Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual y constituyen la base para las intervenciones clínicas posteriores. En este marco, la priorización de la atención tiene como objetivo identificar oportunamente situaciones que comprometan la vida o la estabilidad clínica de la persona, orientando las intervenciones inmediatas y garantizando la continuidad del proceso de atención integral.

Durante este proceso, el talento humano debe:

- **Realizar una evaluación rápida del estado general, identificando:**
  - Signos de compromiso vital.
  - Lesiones físicas visibles o sospechadas.
  - Dolor intenso, sangrado o alteración del estado de conciencia.
- **Identificar riesgos prioritarios, tales como:**
  - Riesgo de embarazo.
  - Exposición a infecciones de transmisión sexual, incluido VIH.
  - Riesgo de auto o heteroagresión.
  - Afectación emocional severa.
- **Definir la prioridad de atención:**
  - Atención inmediata de urgencias, cuando corresponda.
  - Continuación del proceso de atención integral una vez estabilizada la persona.

A continuación, se presenta la secuencia que guía la atención inicial a víctimas de violencia sexual, asegurando una respuesta organizada y oportuna desde el ingreso hasta la continuidad del cuidado.

- Ingreso
- Evaluación rápida
- Identificación de riesgos
- Definición de prioridad
- Continuidad de la atención

Una vez definida la prioridad de atención y garantizada la estabilidad clínica de la persona, el proceso asistencial debe continuar bajo un enfoque de derechos, asegurando su autonomía y participación en cada intervención. En este marco, el consentimiento informado adquiere un papel central como elemento ético y legal que orienta la atención inicial.

1.2. Consentimiento informado

El consentimiento informado constituye un requisito ético y legal en la atención en salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 2011). Su aplicación debe entenderse como un proceso permanente y no como un trámite puntual, particularmente en la atención inicial a víctimas de violencias sexuales. En este momento, el talento humano debe:

- **Explicar de manera clara y comprensible:**
  - Los procedimientos clínicos propuestos.
  - Su finalidad y posibles implicaciones.
  - Las alternativas disponibles.
- **Garantizar que la decisión de la persona sea:**
  - Libre.
  - Voluntaria.
  - Sin presión ni coerción.
- **Obtener consentimiento para:**
  - Valoraciones clínicas.
  - Exámenes físicos o genitales cuando estén indicados.
  - Toma de muestras.
  - Intervenciones terapéuticas iniciales.

- **Respetar el derecho de la persona a:**
  - Aceptar o rechazar procedimientos.
  - Retirar su consentimiento en cualquier momento.
- **En los casos de niños, niñas y adolescentes:**
  - Garantizar su participación acorde con su edad y madurez.
  - Aplicar el principio del interés superior.
  - Obtener la autorización del representante legal.

Una vez garantizado el consentimiento informado como proceso continuo y respetuoso de la autonomía de la persona, la atención inicial debe avanzar hacia la ejecución de las intervenciones clínicas y/o psicosociales correspondientes, asegurando coherencia con los principios previamente establecidos.

1.3. Registro clínico y decisiones asistenciales

El registro clínico inicial constituye un deber técnico, legal y administrativo que respalda la calidad de la atención y la coordinación institucional. Su adecuado diligenciamiento permite organizar la información relevante, orientar decisiones oportunas y garantizar la continuidad del proceso asistencial. En este marco, se presentan los elementos clave que deben considerarse durante su elaboración:

Contenido del registro

- Motivo de consulta y hallazgos clínicos relevantes.
- Evaluación del estado general y riesgos identificados.
- Procedimientos realizados y decisiones clínicas adoptadas.
- Consentimientos otorgados o rechazados.
- Orientaciones brindadas a la persona.

Características del registro

- Claro y objetivo.
- Pertinente desde el punto de vista clínico.
- Libre de juicios de valor o interpretaciones subjetivas.
- Respetuoso de la dignidad y la confidencialidad.

Finalidad del registro

- Garantizar la continuidad del proceso de atención en salud.
- Facilitar la activación de medidas preventivas y terapéuticas.
- Favorecer la articulación con otros profesionales y sectores.

En todos los casos, la atención debe brindarse con enfoque diferencial, de género y de derechos humanos, evitando cualquier forma de revictimización, asegurando la confidencialidad de la información y facilitando la articulación posterior con los servicios de seguimiento clínico, salud mental especializada y las rutas intersectoriales de protección y justicia cuando corresponda.

2. Profilaxis y prevención en salud

La profilaxis y las acciones de prevención secundaria y terciaria constituyen un componente esencial de la atención integral a personas víctimas de violencias sexuales. Su finalidad es reducir el riesgo de infecciones, prevenir embarazos no deseados, detectar complicaciones de manera temprana y mitigar impactos a corto, mediano y largo plazo en la salud física y mental.

De acuerdo con la normativa colombiana vigente, estas intervenciones deben ofrecerse de forma oportuna, integral y sin barreras, como parte obligatoria de la atención inicial y del seguimiento clínico, conforme al Modelo y Protocolo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual (Ministerio de Salud y Protección Social, 2011; Resolución 459 de 2012).

Las decisiones relacionadas con la profilaxis deben fundamentarse en la valoración clínica integral, el análisis del riesgo individual y el respeto por la autonomía de la persona, garantizando siempre el consentimiento informado y la confidencialidad.

Para profundizar en la normativa vigente sobre profilaxis y atención integral, consulte y descargue el Modelo y Protocolo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual. Este documento orienta la práctica profesional y garantiza una actuación conforme a la ley.

Descargue y revise el Modelo y Protocolo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual (Resolución 459 de 2012).

2.1. Profilaxis posexposición

Las medidas de profilaxis posexposición forman parte obligatoria de la atención en salud y deben adoptarse de manera oportuna, según la valoración del riesgo y los

lineamientos técnicos vigentes. Su finalidad es prevenir consecuencias biológicas derivadas de la agresión, tales como infecciones de transmisión sexual, infección por VIH y embarazo no deseado.

La profilaxis posexposición constituye una medida obligatoria en la atención integral a víctimas de violencia sexual y debe iniciarse idealmente dentro de las primeras 72 horas posteriores al evento, conforme a los lineamientos técnicos vigentes (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012).

En el marco de la atención integral a víctimas de violencia sexual, la profilaxis constituye una medida prioritaria para prevenir infecciones y reducir riesgos en salud. Estas intervenciones deben ofrecerse de manera oportuna, conforme a la valoración clínica y a los lineamientos vigentes. A continuación, se presentan los principales tipos de profilaxis que orientan la atención inicial: para infecciones de transmisión sexual, para hepatitis B y la profilaxis posexposición para VIH.

- **Profilaxis para infecciones de transmisión sexual (ITS)**

La profilaxis sindromática busca prevenir infecciones que pueden adquirirse como consecuencia de la violencia sexual, aun cuando no existan síntomas al momento de la consulta. En la atención inicial se debe:

Evaluar el riesgo considerando:

- Tipo de contacto sexual.
- Uso o no de preservativo.
- Presencia de lesiones genitales.
- Tiempo transcurrido desde el hecho.

Informar sobre:

- Objetivo preventivo.
- Medicamentos indicados.
- Posibles efectos adversos.
- Importancia de la adherencia.

Esquemas conforme a lineamientos vigentes para:

- Gonorrea.
- Clamidia.
- Sífilis.
- Tricomoniasis, cuando esté indicada.

Registrar:

- Evaluación del riesgo.
- Consentimiento informado.
- Esquema indicado o rechazado.

- **Profilaxis para hepatitis B**

Debe considerarse de manera sistemática ante el riesgo de transmisión por contacto sexual. Durante la atención inicial, se deben verificar los antecedentes de vacunación para definir la conducta correspondiente según los lineamientos vigentes.

Definir conducta:

- Inicio o continuación del esquema de vacunación.
- Aplicación de inmunoglobulina cuando esté indicada.

Informar sobre:

- Importancia de la vacunación.
- Esquema y tiempos.
- Necesidad de completar dosis.

- **Profilaxis posexposición para VIH (PEP)**

Es una intervención prioritaria ante riesgo de transmisión y debe iniciarse oportunamente según la valoración clínica. Para su indicación, se debe evaluar el riesgo considerando:

Valorar el riesgo según:

- Tipo de acto sexual.
- Presencia de lesiones.
- Estado serológico del agresor, si se conoce.
- Tiempo transcurrido.

Tener en cuenta que:

- Debe iniciarse idealmente dentro de las primeras 72 horas.
- No debe retrasarse por trámites administrativos.

Informar sobre:

- El objetivo del tratamiento.
- La duración estimada.
- La importancia de cumplirlo de manera completa.
- Los posibles efectos secundarios.

Cuando la persona consulte fuera del periodo de mayor efectividad de la PEP, el personal de salud deberá realizar valoración clínica integral, ofrecer pruebas diagnósticas correspondientes y garantizar seguimiento, sin negar la atención ni omitir otras medidas preventivas indicadas.

El talento humano en salud es responsable de asegurar la prescripción oportuna, la entrega completa de los esquemas y la orientación clara sobre adherencia, efectos secundarios y seguimiento. Estas intervenciones deben suministrarse sin discriminación por edad, sexo, afiliación al sistema de salud o existencia de denuncia penal.

2.2. Criterios de indicación y oportunidad

La indicación de la profilaxis posexposición en víctimas de violencias sexuales debe basarse en una valoración clínica integral, oportuna y libre de juicios, que considere el tipo de exposición, el tiempo transcurrido desde el evento, las condiciones de la persona afectada y el contexto en el que ocurrió la agresión. Desde el sector salud, la profilaxis constituye una medida de prevención terciaria esencial para reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual, VIH, hepatitis B y embarazo no deseado, y su aplicación hace parte de la atención inicial de urgencias.

La profilaxis posexposición para VIH y otras infecciones de transmisión sexual debe iniciarse idealmente dentro de las primeras 72 horas, periodo en el que se alcanza mayor eficacia preventiva.

No obstante, la atención en salud no puede negarse si la persona consulta después de este tiempo; en estos casos deben realizarse las pruebas diagnósticas pertinentes, la valoración clínica completa y el seguimiento correspondiente, explicando de manera clara las limitaciones de la profilaxis tardía.

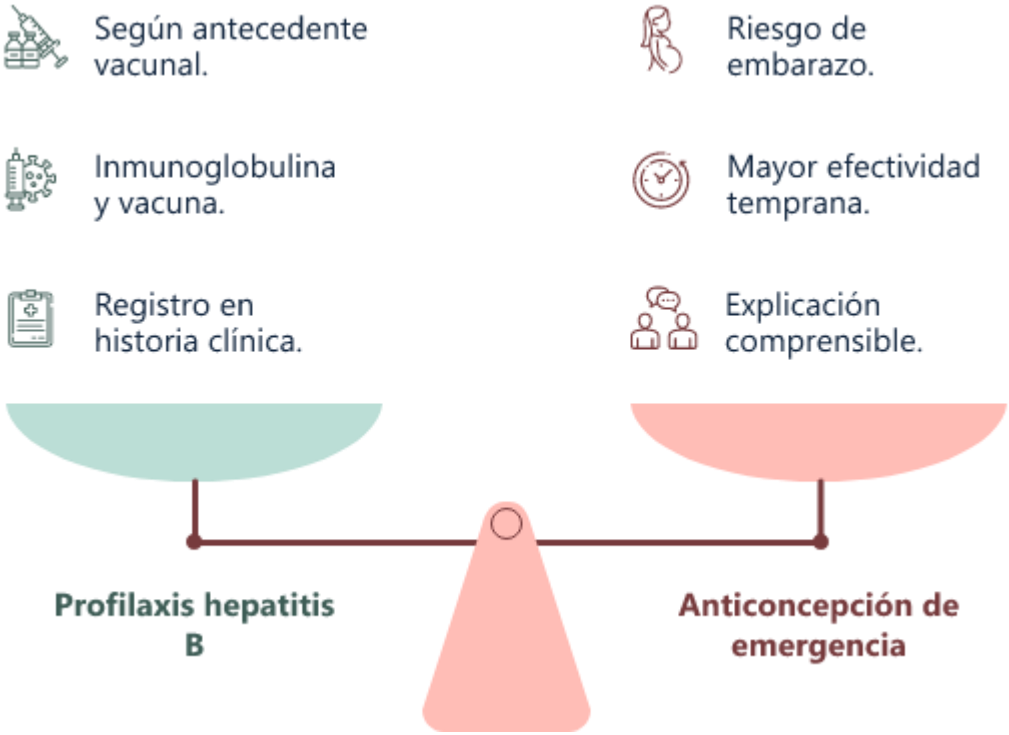
Desde el punto de vista clínico, la profilaxis está indicada cuando exista cualquier forma de contacto sexual con riesgo biológico, incluyendo penetración vaginal, anal u oral, contacto de mucosas con fluidos sexuales, uso de objetos con penetración, o cuando la víctima no pueda precisar completamente lo ocurrido debido a estado de inconsciencia, consumo de sustancias psicoactivas, discapacidad cognitiva o edad. En el marco de la atención integral, no se exige la confirmación del delito ni la identificación del agresor para iniciar la profilaxis, ya que prima el principio de protección de la salud y la vida.

La indicación de anticoncepción de emergencia debe realizarse en todas las mujeres en edad fértil con riesgo de embarazo, preferiblemente dentro de las primeras 120 horas, siendo mayor su efectividad en las primeras 72 horas. En casos de niñas, adolescentes, mujeres con discapacidad o víctimas bajo coacción familiar o institucional, el talento humano en salud debe reforzar la información, el acompañamiento y el enfoque de derechos, garantizando que la decisión sea informada y respetuosa de su autonomía progresiva.

Asimismo, la profilaxis para hepatitis B debe indicarse según el antecedente vacunal de la víctima y el riesgo de exposición, pudiendo incluir la aplicación de inmunoglobulina y vacuna cuando esté clínicamente indicado. Todas estas decisiones deben quedar debidamente registradas en la historia clínica, justificadas técnicamente y explicadas a la persona atendida de manera comprensible y empática.

En coherencia con los criterios de indicación y oportunidad, la siguiente figura sintetiza los elementos clínicos que orientan la toma de decisiones frente a la profilaxis para hepatitis B y la anticoncepción de emergencia. Esta representación visual facilita la comprensión del equilibrio técnico que debe garantizarse durante la atención inicial.

Figura 1. Equilibrio en la indicación de profilaxis y anticoncepción



Profilaxis hepatitis B

- Según antecedente vacunal
- Inmunoglobulina y vacuna
- Registro en historia clínica

Anticoncepción de emergencia

- Riesgo de embarazo
- Mayor efectividad temprana
- Explicación comprensible

2.3. Seguimiento clínico

El seguimiento clínico de la profilaxis es una fase esencial de la atención integral, orientada a garantizar la adherencia al tratamiento, detectar efectos adversos e identificar oportunamente infecciones incidentes. Debe planificarse desde el primer contacto y no considerarse una acción secundaria.

El seguimiento garantiza la efectividad del tratamiento y la seguridad de la persona atendida. Para ello, se deben considerar las siguientes acciones:

- **Control clínico**: evaluación periódica del estado de salud y detección de signos de alarma.
- **Tolerancia al medicamento**: valoración de posibles efectos adversos.
- **Cumplimiento del esquema**: verificación de los 28 días en el caso de la PEP para VIH.
- **Adherencia al tratamiento**: orientación sobre la importancia de no suspender la medicación.
- **Efectos secundarios**: explicación clara sobre posibles reacciones y manejo esperado.
- **Canales de consulta**: disponibilidad de orientación ante síntomas o dudas.

El seguimiento clínico y psicosocial requiere una planificación organizada y articulada. La siguiente tabla resume los momentos diagnósticos, los criterios de control y la integración con la salud mental, garantizando continuidad, confidencialidad y prevención de la revictimización.

Tabla 1. Seguimiento clínico y articulación en salud mental

Componente	Acciones de seguimiento	Momento o criterio	Aspectos clave
Pruebas diagnósticas ITS	VIH, sífilis y otras infecciones de transmisión sexual	Línea basal, 6 semanas, 3 meses y, cuando corresponda, 6 meses	Realizar con confidencialidad y registro adecuado
Hepatitis B	Evaluación serológica según antecedente vacunal	Según esquema y tiempos establecidos	Verificar esquema completo y necesidad de refuerzo
Prueba de embarazo	Confirmación diagnóstica	Cuando exista riesgo de gestación	Aplicar según criterio clínico
Confidencialidad	Protección de la información clínica	Durante todo el proceso	Evitar revictimización
Salud mental	Evaluación del bienestar psicológico	Desde el inicio y durante el seguimiento	Identificar síntomas que afecten adherencia
Remisión especializada	Gestión de apoyo psicológico o psiquiátrico	Cuando se identifiquen alteraciones emocionales	Garantizar continuidad y articulación intersectorial

El cierre del seguimiento debe registrarse en la historia clínica, incluyendo el cumplimiento del tratamiento, los resultados obtenidos y las orientaciones finales brindadas. Este cierre no significa finalizar el acompañamiento, sino integrar el caso al seguimiento clínico general y a la articulación intersectorial correspondiente.

3. Anticoncepción de emergencia e IVE

La anticoncepción de emergencia y la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) forman parte de las prestaciones obligatorias en la atención integral a víctimas de violencias sexuales, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos.

Estas intervenciones deben ofrecerse de manera oportuna, informada y sin barreras, sin exigir denuncia previa ni autorización judicial, conforme a la normatividad colombiana vigente. Su objetivo es prevenir consecuencias adicionales como el embarazo forzado, que constituye una forma de revictimización.

Junto con las garantías legales existentes, el sector salud debe implementar medidas preventivas oportunas para evitar el embarazo derivado de la violencia sexual. En este apartado se presentan las indicaciones, tiempos y consideraciones clínicas que orientan la anticoncepción de emergencia.

Anticoncepción de emergencia

La anticoncepción de emergencia forma parte de las medidas preventivas inmediatas en la atención a víctimas de violencia sexual. Su indicación requiere valorar el riesgo de embarazo, el tiempo transcurrido desde el evento y las condiciones particulares de la persona atendida. A continuación, se presentan las indicaciones clave y los aspectos clínicos esenciales que orientan su aplicación:

Indicaciones clave

- Exposición sexual con riesgo de embarazo.
- Consulta dentro de las primeras 120 horas.
- Mayor eficacia en las primeras 72 horas.

- Aplicable en niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Aspectos clínicos esenciales

- No requiere prueba de embarazo previa.
- No es un método anticonceptivo regular.
- No tiene efecto abortivo.
- Debe acompañarse de consejería clara y sin juicios.

En función del tiempo transcurrido desde el evento de violencia sexual, la eficacia de la anticoncepción de emergencia varía. El siguiente recurso resume los criterios de oportunidad y las conductas recomendadas según el intervalo de tiempo.

- **0 - 72 horas (3 días) Indicación prioritaria**
    - Periodo de mayor eficacia de la anticoncepción de emergencia.
    - Se recomienda administrar lo antes posible tras el evento de violencia sexual.
    - Levonorgestrel (dosis única o dividida).
    - Ulipristal acetato (si está disponible).
- **72 - 120 horas (3 - 5 días) Indicación con menor eficacia**
    - La anticoncepción de emergencia sigue siendo efectiva, aunque con menor eficacia.
    - El ulipristal acetato mantiene mejor efectividad en este periodo comparado con levonorgestrel.
    - No se debe negar la anticoncepción de emergencia por haber superado las 72 horas.

- Continúa siendo una medida válida dentro de la atención integral en salud.

- **Después de 120 horas (>5 días) Evaluación y orientación**

  La anticoncepción de emergencia no es efectiva. por lo tanto se debe:

  - Realizar prueba de embarazo según tiempo transcurrido.
  - Brindar orientación clara sobre derechos sexuales y reproductivos.
  - Activar, si aplica, la ruta para Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) conforme a la normativa vigente.

La anticoncepción de emergencia debe ofrecerse de manera sistemática a toda persona con capacidad de gestar que haya sido víctima de violencia sexual, como parte de la atención inicial en salud. Su administración debe realizarse lo antes posible, preferiblemente dentro de las primeras ciento veinte (120) horas posteriores al evento, sin exigir requisitos adicionales como denuncia penal, autorizaciones administrativas o exámenes previos.

Acceso a la IVE

En el marco de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, es fundamental reconocer las situaciones en las que la ley permite la interrupción voluntaria del embarazo. En Colombia, la violencia sexual constituye una causal legal para acceder a este procedimiento (Corte Constitucional, 2006; Corte Constitucional, 2022). En consecuencia, el sector salud tiene la obligación de activar de manera inmediata la ruta de atención, garantizando el acceso sin barreras administrativas ni exigencia de denuncia previa.

Para asegurar el acceso oportuno y sin barreras, la ruta de atención debe desarrollarse de forma organizada y secuencial. Los siguientes elementos orientan su activación en el ámbito asistencial:

- Confirmación clínica del embarazo.
- Manifestación de voluntad de la persona gestante.
- Certificación del hecho de violencia sexual (sin denuncia obligatoria).
- Información sobre procedimientos según edad gestacional.
- Remisión oportuna si no hay capacidad resolutiva.

La ruta debe activarse de forma inmediata, priorizando la atención y evitando dilaciones que puedan aumentar riesgos físicos o emocionales. En el siguiente recurso se organiza de manera secuencial los pasos que deben garantizarse para el acceso efectivo a la IVE en casos de violencia sexual, desde el ingreso al servicio de salud hasta el seguimiento posterior.

- Ingreso al servicio de salud (víctima de violencia sexual).
- Atención clínica inicial inmediata (enfoque de derechos y sin juicios de valor).
- Confirmación clínica del embarazo (prueba según tiempo de gestación).
- Manifestación de voluntad de la persona gestante.
- Certificación del hecho de violencia sexual (sin exigir denuncia penal).
- Información clara y completa sobre la IVE (procedimientos, riesgos, alternativas).
- Consentimiento informado (libre, voluntario y documentado).
- Selección del procedimiento según edad gestacional.

- Realización de la IVE (en IPS habilitada).
- Seguimiento clínico y en salud mental.

La violencia sexual constituye una causal legal para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Colombia. En estos casos, los servicios de salud tienen la obligación de brindar información completa, veraz y oportuna sobre este derecho, así como de garantizar la activación de la ruta correspondiente sin dilaciones, barreras administrativas ni exigencia de denuncia penal o autorización judicial.

La garantía del consentimiento informado es obligatoria dentro de la ruta de atención y constituye un componente esencial del proceso asistencial.

Consentimiento informado para la IVE

El consentimiento informado es un requisito ético y legal indispensable. Debe garantizar que la decisión sea libre, voluntaria y consciente, sin presiones externas. Este proceso implica brindar información clara, suficiente y comprensible sobre el procedimiento, sus implicaciones, alternativas y posibles riesgos, respetando la autonomía y la dignidad de la persona.

En niñas, adolescentes y personas con discapacidad, el consentimiento debe ajustarse al principio de autonomía progresiva y a los apoyos necesarios para garantizar comprensión.

Para su adecuada aplicación dentro de la ruta de atención, se deben considerar los siguientes principios:

- Información comprensible, veraz y suficiente.
- Respeto por la autonomía y la dignidad.

- Adecuación al nivel de comprensión, edad y condición de la persona.
- En niñas y adolescentes, aplicación del principio de autonomía progresiva.
- En personas con discapacidad, ajustes razonables para garantizar comprensión.

El consentimiento informado para la interrupción voluntaria del embarazo debe formalizarse de manera libre y voluntaria, dejando constancia en la historia clínica y asegurando el enfoque diferencial y la protección integral de derechos.

- **Identificación y abordaje de barreras**

El acceso efectivo a la IVE exige la identificación y eliminación activa de barreras institucionales que puedan limitar el ejercicio del derecho. Entre las más frecuentes se encuentran la desinformación sobre la normatividad vigente, la exigencia indebida de denuncia penal, retrasos administrativos, remisiones injustificadas, estigmatización o la aplicación inadecuada de la objeción de conciencia.

Los servicios de salud deben adoptar medidas para prevenir estas situaciones, incluyendo la capacitación continua del talento humano, la implementación de protocolos claros y la remisión inmediata cuando exista objeción de conciencia individual. En ningún caso la objeción de conciencia puede ser institucional ni constituir un obstáculo para la garantía del derecho a la atención en salud.

- **Procedimientos según edad gestacional**

La selección del procedimiento para la IVE debe realizarse de acuerdo con la edad gestacional, las condiciones clínicas de la persona y la capacidad resolutiva del servicio de salud, garantizando siempre condiciones de seguridad, confidencialidad y trato digno.

En términos generales, durante las primeras semanas pueden utilizarse métodos farmacológicos o procedimientos ambulatorios de menor complejidad. A medida que avanza la edad gestacional, pueden requerirse intervenciones clínicas de mayor complejidad y seguimiento especializado. En todos los casos debe garantizarse manejo adecuado del dolor, acompañamiento emocional y seguimiento posterior.

La decisión sobre el procedimiento debe adoptarse mediante un proceso de información clara y consentimiento informado, respetando la autonomía y el enfoque diferencial.

4. Atención en salud mental

El seguimiento en salud mental constituye un componente esencial de la atención integral, orientado a acompañar el proceso de recuperación emocional y prevenir posibles afectaciones posteriores. Su desarrollo implica acciones continuas, responsables y articuladas que fortalecen el bienestar de la persona atendida. Comprender estos elementos permite consolidar una atención más segura y humanizada. A continuación, se presenta un pódcast que amplía estos aspectos y orienta su aplicación en el contexto asistencial.

Podcast: Atención en salud mental

Nombre del programa: Atención en salud mental **Personajes:** hombre, mujer.
Mujer: la atención en casos de violencia sexual no se limita a la intervención inicial. Hombre: el cuidado también pasa por el acompañamiento emocional y la atención en salud mental. Mujer: porque el impacto no es solo físico. También puede afectar profundamente las emociones, la confianza y la manera en que la persona se relaciona con quienes la rodean. Hombre: por eso, la atención en salud mental es una parte esencial de la atención integral.

Mujer: El seguimiento emocional permite acompañar a la persona en su proceso de recuperación, prevenir secuelas y fortalecer su bienestar a mediano y largo plazo.

Hombre: implica evaluar su estado emocional, monitorear posibles síntomas postraumáticos y mantener un apoyo constante y respetuoso.

Mujer: en los primeros momentos, los primeros auxilios psicológicos cumplen un papel fundamental.

Hombre: escuchar con respeto, validar las emociones y brindar información clara puede marcar una diferencia significativa.

Mujer: no se trata de hacer psicoterapia, sino de ofrecer contención y proteger la estabilidad emocional.

Hombre: también es fundamental identificar las señales de alerta en la salud mental.

Mujer: la valoración del riesgo para sí misma y el acompañamiento oportuno permiten brindar una atención más segura e integral.

Hombre: cada intervención puede marcar una diferencia real en el proceso de sanación.

Mujer: por eso, activar las rutas necesarias y trabajar en equipo permite brindar una atención verdaderamente integral.

Hombre: brindar una atención integral en situaciones de violencia sexual

implica mirar más allá del momento inicial y reconocer la importancia del acompañamiento emocional.

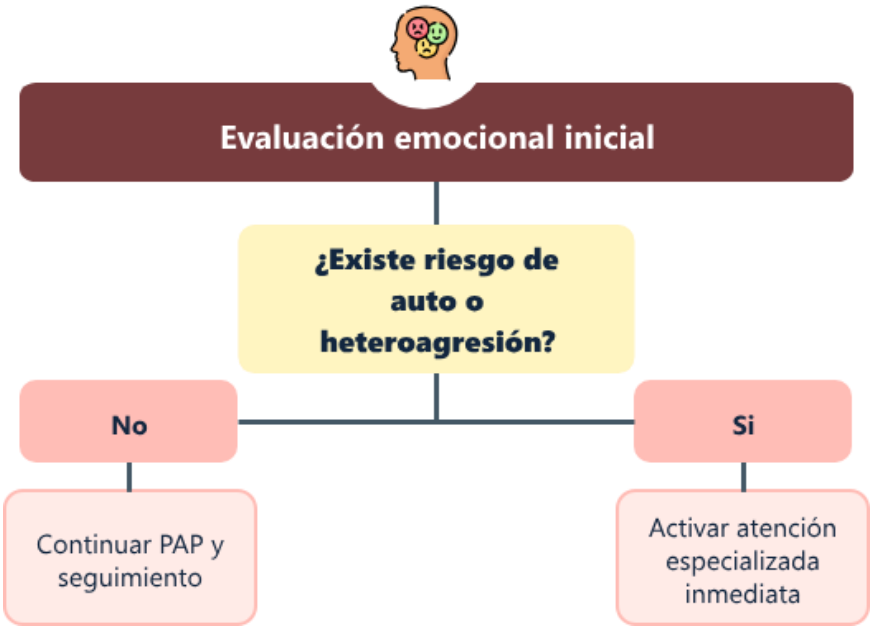
Mujer: reconocer, acompañar y actuar a tiempo hace parte de ese compromiso.

Hombre: cuidar la salud mental también es proteger la vida.

[Fin del programa]

Después de escuchar el pódcast, se presenta la figura 2, que organiza de manera visual los componentes de la atención inicial en salud mental. El esquema muestra la evaluación emocional inicial, la identificación de posibles riesgos y las acciones que deben realizarse según cada caso. Esta representación facilita la comprensión del proceso y apoya su aplicación en la práctica asistencial.

Figura 2. Componentes de la atención inicial en salud mental en casos de violencia sexual



Si bien la intervención inicial permite contener la crisis y estabilizar emocionalmente a la persona, en algunos casos pueden identificarse condiciones que requieren valoración y manejo especializado. En estos escenarios, el servicio de salud debe activar de manera oportuna la remisión correspondiente, garantizando continuidad y protección integral.

Cuando la intervención inicial no resulta suficiente, es necesario definir los criterios que orientan la remisión oportuna a la atención especializada en salud mental:

- **Criterios de remisión a atención especializada**

La remisión a atención especializada en salud mental procede cuando se identifican condiciones que superan el alcance de la intervención inicial.

Entre los criterios más frecuentes se encuentran:

- Síntomas persistentes de ansiedad, depresión o estrés postraumático.
- Riesgo de autoagresión o heteroagresión.
- Trastornos mentales previos exacerbados.
- Víctimas niñas, niños o adolescentes.
- Violencias sexuales reiteradas o crónicas.
- Ausencia de redes de apoyo.

La remisión debe realizarse de manera oportuna, efectiva y acompañada, evitando traslados innecesarios o barreras administrativas que puedan afectar la continuidad del proceso.

5. Continuidad y seguimiento

La continuidad es un principio fundamental en el proceso integral dirigido a víctimas de violencias sexuales, ya que garantiza que las acciones iniciadas en la fase inmediata no se interrumpan y se desarrollen de manera organizada y articulada. Su propósito es asegurar un acompañamiento sostenido en el tiempo, evitar la fragmentación de los servicios y prevenir nuevas situaciones de vulneración, mediante la coordinación entre los diferentes niveles y sectores involucrados.

Este proceso debe planearse desde el primer contacto con la víctima, considerando su evolución física, emocional y social. Asimismo, requiere seguimiento periódico y articulación entre las entidades responsables, con el fin de garantizar que las medidas adoptadas respondan de manera oportuna a las necesidades identificadas y se ajusten cuando sea necesario.

Para garantizar una continuidad efectiva, es necesario estructurar la planeación del seguimiento clínico, definiendo acciones, tiempos y mecanismos de articulación que permitan dar respuesta integral a las necesidades identificadas:

- **Planeación de los seguimientos clínicos**

La planeación del seguimiento clínico debe realizarse de manera individualizada, teniendo en cuenta el tipo de violencia sexual, el momento de consulta, los riesgos identificados y las condiciones particulares de la víctima.

Elementos esenciales de la planeación:

- Definición clara de controles clínicos y tiempos de seguimiento.
- Programación de pruebas diagnósticas para ITS, VIH y embarazo.
- Seguimiento a la adherencia de tratamientos y profilaxis.

- Articulación con salud mental y otras especialidades.
- Identificación temprana de signos de alarma.

La adecuada planeación del seguimiento permite identificar oportunamente situaciones que requieren continuidad dentro del mismo servicio o la necesidad de remitir a otros niveles de atención. En este contexto, cuando la complejidad del caso supera la capacidad resolutiva del equipo inicial o se requiere intervención especializada, se hace necesario activar los mecanismos de referencia y contrarreferencia como parte integral del proceso asistencial.

- **Referencia y contrarreferencia**

La referencia y contrarreferencia son mecanismos esenciales para garantizar la continuidad de la atención cuando se requiere mayor capacidad resolutiva.

Criterios para referencia:

- Necesidad de atención especializada en salud mental.
- Complicaciones clínicas derivadas de la violencia sexual.
- Requerimiento de procedimientos de mayor complejidad.
- Atención de niñas, niños y adolescentes en contextos de alto riesgo.

La contrarreferencia debe asegurar que la información clínica relevante regrese al servicio remitente, permitiendo la continuidad del seguimiento y evitando duplicaciones innecesarias o vacíos en la atención.

- **Cierre del proceso asistencial**

El cierre del proceso asistencial corresponde a un acto clínico-administrativo que se realiza cuando se han cumplido las acciones programadas de intervención y seguimiento, y se han alcanzado los objetivos definidos para el caso.

Este cierre implica:

- Finalizar el seguimiento establecido.
- Consolidar los resultados diagnósticos obtenidos.
- Verificar la estabilidad clínica y emocional de la persona.
- Brindar orientación final sobre cuidados y rutas disponibles.
- Articular con otros sectores cuando sea necesario.

El cierre no significa abandono del acompañamiento, sino la culminación formal del proceso desde el sector salud, asegurando que la persona cuente con información clara sobre las rutas de apoyo disponibles en caso de requerirlas.

6. Registro y vigilancia

El registro y la vigilancia epidemiológica de los casos de violencias sexuales son una obligación legal, clínica y ética del sector salud. Estos procesos garantizan la continuidad de la atención, la activación de rutas intersectoriales y la generación de información confiable para la toma de decisiones en salud pública.

Toda la información debe registrarse de manera veraz, oportuna, completa y confidencial, evitando juicios de valor o descripciones innecesarias que puedan generar revictimización.

Para garantizar la trazabilidad del caso y el cumplimiento de las obligaciones legales del sector salud, el proceso de registro y vigilancia se desarrolla a través de tres componentes complementarios: el registro clínico y administrativo, la notificación en SIVIGILA y el registro en RIPS:

- **Registro clínico y administrativo**

El registro clínico inicia desde el primer contacto con el servicio de salud y se mantiene durante todo el proceso de intervención y seguimiento. Debe realizarse con enfoque diferencial, respetando la dignidad de la persona y garantizando confidencialidad.

Componentes del registro clínico

- Identificación con enfoque diferencial.
- Motivo de consulta y relato objetivo.
- Hallazgos clínicos relevantes.
- Diagnósticos asociados.
- Intervenciones realizadas.

- Consentimientos informados.

- **Notificación en SIVIGILA**

La notificación en SIVIGILA es el proceso mediante el cual el sector salud reporta obligatoriamente los casos de violencia sexual al sistema nacional de vigilancia, con el fin de realizar seguimiento epidemiológico y orientar acciones de prevención y control.

Elementos clave de la notificación

- Reportar el caso dentro de los tiempos establecidos.
- Diligenciar correctamente la ficha epidemiológica.
- Garantizar la confidencialidad de la información.
- Contribuir al análisis y monitoreo en salud pública.

- **Registro en RIPS**

El Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) constituye un componente esencial del proceso administrativo y de gestión en los casos de violencias sexuales, ya que permite documentar los servicios prestados y garantizar la trazabilidad institucional.

Elementos clave del registro en RIPS

- Registrar correctamente los datos del servicio prestado.
- Codificar diagnósticos y procedimientos realizados.
- Garantizar la trazabilidad administrativa del caso.
- Respaldar la gestión y facturación institucional.

En coherencia con lo anterior, el registro en RIPS exige criterios técnicos claros que garanticen precisión y consistencia. A continuación, se presentan los aspectos clave para su adecuado diligenciamiento y su importancia en la atención integral a víctimas de violencias sexuales.

Aspectos clave para el registro adecuado en RIPS

- Codificar correctamente los diagnósticos asociados a violencias sexuales, conforme a la clasificación vigente.
- Registrar los servicios prestados en urgencias, consulta externa, hospitalización o modalidad ambulatoria.
- Incluir los procedimientos realizados, como profilaxis, anticoncepción de emergencia, atención en salud mental y controles clínicos.
- Garantizar correspondencia entre el RIPS y la información consignada en la historia clínica.
- Realizar el registro oportunamente para asegurar la trazabilidad del caso.

Importancia del RIPS en la atención integral

- Soportar la facturación y reconocimiento de los servicios prestados.
- Facilitar el seguimiento institucional de los casos atendidos.
- Identificar brechas en la prestación de servicios de salud.
- Contribuir al análisis de la oferta y demanda de atención.
- Apoyar la planeación y mejora continua de los servicios.

La información generada a partir del registro clínico, la notificación en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y el registro en los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) constituye un insumo estratégico para el

seguimiento de los casos de violencias sexuales y para la toma de decisiones en salud pública, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social (2012) y del Instituto Nacional de Salud (s.f.).

Su adecuado uso permite trascender la atención individual y orientar acciones institucionales y territoriales de prevención, control y mejora de la calidad de los servicios de salud. De esta manera, la información clínica no se limita al ámbito asistencial, sino que se transforma en un instrumento de gestión y planeación en salud pública.

El manejo de esta información debe realizarse bajo principios estrictos de confidencialidad, reserva y uso ético, garantizando que los datos no sean utilizados para fines distintos a los establecidos ni generen estigmatización, exposición indebida o revictimización de las personas atendidas, en concordancia con la normativa sobre historia clínica y protección de datos en salud.

Desde el ámbito institucional y territorial, la información consolidada permite identificar patrones de ocurrencia, grupos en mayor situación de vulnerabilidad, contextos de riesgo y brechas en el acceso a los servicios, fortaleciendo así la respuesta del sector salud frente a las violencias sexuales.

7. Articulación forense

La atención integral a víctimas de violencias sexuales requiere una adecuada coordinación entre el sector salud y el sistema de justicia, con el fin de contribuir a la investigación del delito sin afectar la prioridad clínica, la dignidad de la persona atendida ni el principio de no revictimización. En este marco, el rol del sector salud es técnico y delimitado, ya que se centra en documentar los hallazgos clínicos, preservar los elementos materiales probatorios cuando corresponda y facilitar la remisión a las autoridades competentes, garantizando en todo momento que la atención en salud mantenga su carácter prioritario.

Para comprender el alcance de la articulación forense, es necesario identificar los elementos que orientan la coordinación entre el sector salud y las autoridades competentes. A continuación, se presentan los aspectos relacionados con la coordinación con medicina legal, la identificación de posibles elementos probatorios, la cadena de custodia y los límites del rol del sector salud, así como las acciones dirigidas a prevenir la revictimización:

- **Coordinación del sector salud con medicina legal**

La articulación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) debe desarrollarse bajo criterios de oportunidad, claridad de competencias y respeto por la autonomía de la víctima.

Para asegurar una actuación adecuada, deben observarse los siguientes principios:

- Prioridad absoluta de la atención en salud.
- Respeto por la autonomía y decisión informada de la víctima.

- Claridad en los roles institucionales.
- Evitación de duplicidad de procedimientos.
- Comunicación interinstitucional efectiva.

- **Posibles elementos probatorios**

Los posibles elementos probatorios son materiales o evidencias que pueden identificarse durante la atención en salud y que podrían aportar información relevante para la investigación judicial, sin afectar la prioridad asistencial ni la dignidad de la persona atendida.

Elementos que pueden identificarse durante la atención:

- Recolectar muestras biológicas pertinentes.
- Preservar prendas de vestir relacionadas con el evento.
- Identificar objetos asociados a los hechos.
- Registrar hallazgos clínicos relevantes.
- Entregar los elementos a la autoridad competente.

- **Cadena de custodia y límites del rol del sector salud**

La cadena de custodia es el conjunto de procedimientos que garantizan la integridad y autenticidad de los elementos materiales probatorios desde su recolección hasta su análisis final. El sector salud participa únicamente en las etapas iniciales, dentro de los límites de su competencia.

Límites claros del rol del sector salud:

- No investigar el delito.

- No interrogar a la víctima con fines judiciales.
- No emitir conceptos periciales.
- No asumir funciones de policía judicial.

- **Prevención de revictimización**

La revictimización en el proceso forense se presenta cuando la persona afectada es sometida a procedimientos innecesarios, repetitivos o invasivos que pueden profundizar el daño sufrido. En este contexto, el sector salud tiene la responsabilidad ética y profesional de prevenir activamente cualquier práctica que genere nuevas afectaciones durante la atención.

Acciones clave para prevenir la revictimización:

- Evitar interrogatorios reiterativos o innecesarios.
- Limitar la repetición injustificada de exámenes físicos.
- Brindar información clara, suficiente y anticipada.
- Respetar el ritmo y las decisiones de la persona.
- Coordinar adecuadamente con las instituciones competentes.

Con el fin de facilitar la comprensión del alcance del rol del sector salud en el proceso forense, la siguiente tabla resume las responsabilidades institucionales y las acciones que no le corresponden al personal sanitario, contribuyendo a prevenir extralimitaciones y posibles responsabilidades legales.

Tabla 2. Límites y responsabilidades del sector salud en el abordaje forense

Responsabilidades del sector salud	Acciones que no le corresponden
Documentar hallazgos clínicos	Investigar el delito
Preservar elementos probatorios iniciales	Realizar interrogatorios judiciales
Garantizar consentimiento informado	Emitir conceptos periciales
Remitir a medicina legal	Asumir funciones de policía judicial
Priorizar la atención clínica	Determinar responsabilidad penal

Esta diferenciación fortalece la seguridad jurídica institucional y protege los derechos de la víctima.

8. Activación de rutas

La activación de rutas intersectoriales es un componente esencial de la atención integral a víctimas de violencias sexuales, en cumplimiento del principio de corresponsabilidad del Estado en la garantía de derechos. Dado que estas situaciones requieren una respuesta articulada, los sectores salud, justicia y protección deben actuar de manera coordinada.

En este proceso, el sector salud cumple un papel estratégico como puerta de entrada al sistema, por lo que la activación de las rutas debe realizarse de forma inmediata y paralela a la atención clínica, sin condicionarse a la denuncia penal. Su propósito es asegurar protección, acceso a la justicia y restablecimiento de derechos. A continuación, se desarrollan los elementos que estructuran su implementación dentro de la atención integral:

- **Activación inmediata de las rutas de atención**

La activación de las rutas debe realizarse de manera inmediata y paralela a la atención clínica, sin condicionarse a la denuncia penal o a decisiones judiciales. Su finalidad es garantizar protección, acceso a la justicia y continuidad en la atención integral.

Esta activación es prioritaria en situaciones como:

- Violencias sexuales recientes.
- Riesgo para la vida o la integridad de la víctima.
- Casos que involucren niñas, niños y adolescentes.
- Personas con discapacidad o en situación de especial vulnerabilidad.
- Violencias sexuales reiteradas o en contexto intrafamiliar.

Estas activaciones de rutas aseguran una respuesta oportuna y centrada en la protección de derechos.

- **Principios que orientan la activación**

La actuación intersectorial debe fundamentarse en principios que aseguren una respuesta protectora y centrada en la dignidad de la persona afectada.

  - Centralidad de la víctima.
  - Oportunidad y simultaneidad en la intervención.
  - Enfoque diferencial.
  - No revictimización.
  - Confidencialidad y reserva de la información.

Estos principios garantizan que la intervención sea proporcional al riesgo y respetuosa de los derechos.

- **Rol operativo del sector salud como articulador**

El sector salud actúa como articulador operativo y no como autoridad jerárquica sobre otros sectores. Su función es facilitar el acceso efectivo a los servicios de protección y justicia, evitando la fragmentación de la atención.

Funciones operativas:

  - Identificar las necesidades intersectoriales del caso.
  - Informar a la víctima sobre las rutas disponibles.
  - Facilitar el contacto con las entidades competentes.
  - Realizar remisiones formales y documentadas.
  - Hacer seguimiento a la activación efectiva de las rutas.

Aunque no reemplaza las funciones de justicia o protección, debe prevenir omisiones que afecten el acceso a los derechos.

- **Comunicación interinstitucional efectiva**

La comunicación interinstitucional es un factor crítico para el funcionamiento adecuado de las rutas. Debe ser clara, oportuna, respetuosa de las competencias y centrada en la protección de la víctima.

Características principales:

- Uso de canales institucionales definidos.
- Información suficiente, pertinente y objetiva.
- Evitar duplicidad de solicitudes a la víctima.
- Registro de las comunicaciones realizadas.
- Seguimiento a los compromisos adquiridos.

Una comunicación deficiente puede generar retrasos, pérdida de información y revictimización institucional.

La comunicación deficiente entre sectores puede generar retrasos, pérdida de información y situaciones de revictimización institucional. Por esta razón, la coordinación debe desarrollarse de manera simultánea y no secuencial, activando en paralelo las acciones de salud, protección y justicia para evitar que la respuesta dependa de trámites sucesivos que incrementen el riesgo para la víctima.

La activación simultánea de las rutas intersectoriales fortalece la respuesta institucional y mejora la protección integral. A continuación, se presentan los sectores

que intervienen en este proceso y los beneficios que se derivan de su articulación oportuna:

Sectores

- Salud.
- Justicia (Fiscalía, Policía Judicial).
- Protección (ICBF, Comisarías de Familia).
- Sector social y comunitario, cuando aplique.

Beneficios

- Reducción de tiempos de respuesta.
- Disminución de cargas institucionales para la víctima.
- Mayor eficacia en la protección.
- Prevención de nuevas situaciones de violencia.

9. Acceso a la justicia

El acceso a la justicia es un derecho fundamental de las víctimas de violencias sexuales y una obligación del Estado. Desde el sector salud, este derecho implica brindar orientación clara, respetar la autonomía y evitar barreras que limiten la activación de las rutas institucionales. El talento humano en salud cumple un rol facilitador, sin sustituir a la autoridad judicial, actuando dentro del marco legal y priorizando la protección y la no revictimización. La activación del componente judicial se realiza mediante el aviso a las autoridades competentes, conforme a la normatividad vigente y sin generar retrasos en la atención clínica, garantizando que la información compartida sea estrictamente necesaria y confidencial.

En el marco del acceso a la justicia, el aviso a las autoridades competentes permite activar el componente judicial y las medidas de protección correspondientes. A continuación, se presentan las entidades que intervienen en este proceso y cumplen funciones específicas dentro de la ruta institucional:

- Fiscalía General de la Nación
- Policía Judicial
- Comisarías de Familia
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Existen distintas modalidades de aviso que deben explicarse de manera clara para facilitar decisiones informadas por parte de la víctima. Estas modalidades determinan el tipo de actuación institucional que se activa en el marco del acceso a la justicia.

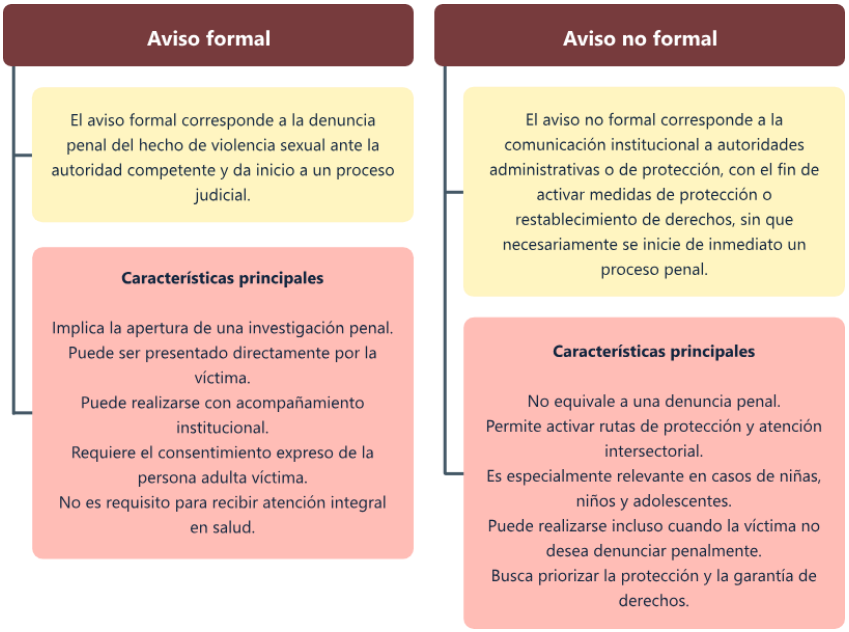
Tipos de aviso

- **Aviso formal:** activa directamente la actuación judicial mediante la denuncia ante autoridad competente.
- **Aviso no formal:** permite activar mecanismos administrativos de protección sin iniciar de manera inmediata un proceso penal.

El talento humano en salud debe informar las implicaciones de cada modalidad con enfoque de derechos, sin presionar ni condicionar la atención a la decisión de denunciar. La prestación de servicios de salud no puede depender de la interposición de denuncia.

Para facilitar la comprensión de estas diferencias y sus implicaciones jurídicas y protectoras, a continuación, se presenta un esquema comparativo entre el aviso formal y el aviso no formal en el contexto de la atención a víctimas de violencias sexuales.

Figura 3. Diferencias entre aviso formal y aviso no formal en casos de violencia sexual



Nota. Adaptado de la Ley 906 de 2004, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1146 de 2007 y la Ley 1257 de 2008.

La aplicación del deber de denunciar en casos de violencias sexuales exige un análisis diferenciado que equilibre la protección de la víctima con el respeto por sus derechos y autonomía. No se trata de una obligación automática, sino de una actuación orientada por principios garantistas y ajustada a la condición de la persona afectada. A continuación, se presentan los criterios que orientan esta aplicación, así como su desarrollo específico en personas adultas, en niñas, niños y adolescentes, y en situaciones excepcionales que requieren medidas reforzadas de protección.

Principios orientadores

La aplicación del deber de denunciar debe regirse por criterios garantistas que aseguren la protección integral de la víctima y el respeto por sus derechos. Estos principios orientan una actuación proporcional, ética y libre de revictimización.

- Protección integral de la víctima.
- Respeto por la autonomía en personas adultas.
- Interés superior de niñas, niños y adolescentes.
- Proporcionalidad y necesidad.
- No revictimización.

Aplicación en personas adultas

En personas adultas, el deber de denunciar se aplica con respeto por la autonomía y la capacidad de decisión. La información debe brindarse de manera clara, sin presiones ni condicionamientos en la atención en salud.

- Derecho a recibir información clara sobre la denuncia.
- No puede obligarse a presentar denuncia penal.
- Se respeta el secreto profesional, salvo excepciones legales.
- Puede activarse aviso no formal si existe riesgo.

Aplicación en niñas, niños y adolescentes

En niñas, niños y adolescentes, la protección prevalece sobre la autonomía decisional. El aviso a las autoridades hace parte del proceso de restablecimiento de derechos y responde al principio de interés superior del menor.

- El aviso es obligatorio dentro del proceso de restablecimiento de derechos.
- No depende de la voluntad del NNA o su familia.
- Debe realizarse de forma inmediata y documentada.

Situaciones excepcionales en personas adultas

Existen situaciones excepcionales en las que el aviso puede ser obligatorio incluso en personas adultas, cuando se identifican riesgos graves que comprometen la vida, la integridad o la seguridad.

El aviso procede cuando exista:

- Riesgo inminente para la vida o integridad.
- Amenaza grave o reiterada.
- Incapacidad de la víctima para protegerse.
- Orden judicial expresa.

Alcance del secreto profesional

El secreto profesional constituye una garantía ética y legal en la atención a víctimas de violencias sexuales. Su finalidad es proteger la información sensible y preservar la confianza en la relación asistencial.

- Protección de la historia clínica.
- Acceso restringido a personal autorizado.
- Prohibición de divulgar información sin justificación legal.
- Uso exclusivo para fines asistenciales o legales autorizados.
- Confidencialidad en comunicaciones interinstitucionales.

Criterios de actuación ante excepciones

Cuando se configura una excepción legal, el manejo de la información debe realizarse con prudencia, criterio técnico y enfoque de derechos, evitando afectaciones adicionales a la víctima.

- Informar a la víctima cuando sea posible.
- Evitar divulgar detalles innecesarios.
- Utilizar canales institucionales formales.
- Documentar la decisión adoptada.
- Priorizar la protección y la no revictimización.

Desde el acceso a la justicia, el manejo adecuado del secreto profesional y de sus excepciones constituye un elemento clave para garantizar una actuación ética, legal y centrada en la víctima. La protección de la confidencialidad fortalece la confianza en los servicios de salud, mientras que la aplicación responsable de las excepciones permite

activar los mecanismos de protección y judicialización cuando la ley lo exige. De este modo, se asegura un equilibrio entre el respeto por la autonomía, la garantía de derechos y la obligación institucional de prevenir riesgos y evitar nuevas formas de victimización.

10. Procedimientos de protección según el contexto

Los procedimientos de protección en casos de violencias sexuales tienen como propósito prevenir la repetición del hecho, salvaguardar la vida e integridad de la víctima y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. Estas medidas deben activarse de manera oportuna, diferencial y articulada, considerando el contexto en que ocurrió la violencia y las condiciones particulares de la persona afectada.

En este marco, el sector salud cumple un papel esencial en la identificación del riesgo, la activación de las rutas de protección y el seguimiento intersectorial, actuando con enfoque preventivo y articulador, sin asumir competencias judiciales o administrativas de otros sectores. En contextos intrafamiliares, el riesgo de reiteración suele incrementarse debido a factores como la convivencia, la dependencia económica o los vínculos de cuidado, lo que exige una respuesta inmediata y reforzada de protección.

Los procedimientos de protección deben ajustarse al contexto en que ocurre la violencia sexual, ya que los riesgos y las condiciones de vulnerabilidad varían. La respuesta institucional exige medidas oportunas, diferenciadas y articuladas, orientadas a proteger la vida, la integridad y los derechos de la víctima. A continuación, se presentan las acciones de protección según el ámbito de ocurrencia.

- **Protección en casos de violencia intrafamiliar**
  - Activación inmediata de la ruta de protección.
  - Aviso a Comisarías de Familia o autoridad competente.
  - Valoración del riesgo de permanencia en el entorno familiar.
  - Coordinación con servicios sociales y de protección.
  - Seguimiento continuo desde el sector salud.

- **Protección en casos de violencia sociopolítica y conflicto armado**
  - Evaluación de riesgo individual y colectivo.
  - Articulación con entidades de atención a víctimas del conflicto.
  - Coordinación con programas de protección especializados.
  - Garantía reforzada de confidencialidad.
  - Aplicación de enfoque diferencial étnico y territorial.
- **Protección en casos de violencia en otros ámbitos**
  - Identificación del ámbito de ocurrencia.
  - Activación de rutas institucionales específicas.
  - Articulación con autoridades administrativas o laborales.
  - Implementación de medidas para prevenir la repetición del hecho.
  - Seguimiento desde el sector salud, cuando corresponda.

11. Programas institucionales de protección

Los programas institucionales de protección constituyen mecanismos especializados del Estado orientados a salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de personas víctimas de violencias sexuales que enfrentan riesgos graves, extraordinarios o persistentes. Estos programas se enmarcan en el deber de protección reforzada y se activan de manera complementaria a las acciones desarrolladas por los sectores salud, justicia y protección administrativa. Aunque el sector salud no administra dichos programas, desempeña un papel fundamental en la identificación temprana del riesgo, la orientación a la persona afectada y la activación oportuna de las rutas correspondientes. Cuando el nivel de amenaza supera las medidas ordinarias de protección, pueden implementarse mecanismos especializados de alcance nacional.

11.1. Tipos de programas institucionales

En el marco del deber de protección reforzada del Estado, existen programas institucionales especializados orientados a salvaguardar la vida, integridad y libertad de personas víctimas de violencias sexuales que enfrentan riesgos graves, extraordinarios o persistentes. Estos programas operan bajo criterios técnicos de evaluación del riesgo y se articulan con las acciones del sector salud, justicia y protección administrativa, constituyendo mecanismos complementarios que se activan cuando las medidas ordinarias resultan insuficientes. Su finalidad es garantizar condiciones de seguridad que permitan a la víctima ejercer sus derechos sin exponerse a nuevas amenazas o situaciones de violencia.

Dentro de este marco institucional, uno de los principales mecanismos de protección es el Programa de Prevención y Protección del Ministerio del Interior, el cual opera a nivel nacional y está orientado a la atención de situaciones en las que se

configuran niveles de riesgo extraordinario o extremo. Su activación responde a una valoración técnica especializada y constituye una medida de protección reforzada cuando las acciones ordinarias no resultan suficientes para garantizar la seguridad de la víctima.

- **Programa de prevención y protección**

Este programa tiene como finalidad proteger a personas, grupos o comunidades que se encuentren en riesgo extraordinario o extremo como consecuencia de amenazas contra su vida, integridad o libertad. Su activación se fundamenta en criterios técnicos de evaluación del riesgo y en el principio de debida diligencia estatal.

La evaluación del riesgo y la activación de medidas de protección se fundamentan en un marco constitucional y reglamentario que orienta la actuación del Estado frente a situaciones de amenaza extraordinaria o extrema. A continuación, se presenta la evolución normativa que sustenta el Programa de Prevención y Protección:

- **1991**
  - **Constitución Política de Colombia**
    - Establece la protección de la vida, la integridad y la igualdad (arts. 11, 12 y 13).
    - Constituye la base constitucional del deber de protección reforzada.
- **2004**
  - **Ley 906 de 2004 – Código de Procedimiento Penal**
    - Regula el proceso penal y la intervención de víctimas y testigos.

        - Sienta las bases para la protección de participantes procesales en riesgo.

- **2008**
    - **Ley 1257 de 2008**
        - Establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar violencia contra la mujer.
        - Fortalece el enfoque de protección integral para víctimas de violencias sexuales.
- **2011**
    - **Decreto 4912 de 2011**
        - Organiza el Programa de Prevención y Protección.
        - Define principios y criterios generales de evaluación del riesgo.
- **2015 – Presente**
    - **Lineamientos técnicos y protocolos internos del Ministerio del Interior**
        - Desarrollan metodologías para la valoración técnica del riesgo.
        - Orientan la actuación de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
        - Apoyan la toma de decisiones para activar y hacer seguimiento a las medidas.

La evolución normativa evidencia cómo el ordenamiento jurídico colombiano ha fortalecido progresivamente los mecanismos de protección, consolidando un sistema técnico y reglamentario que permite evaluar el riesgo y adoptar medidas oportunas para salvaguardar la vida, la integridad y el ejercicio de derechos.

- **Programa de protección a víctimas y testigos**

El Programa de protección a víctimas y testigos se fundamenta en el marco normativo vigente, que comprende la Constitución Política de Colombia, la Ley 906 de 2004, la Ley 1257 de 2008 y los reglamentos internos de la Fiscalía General de la Nación. Su finalidad es garantizar la seguridad, confidencialidad y acceso efectivo a la justicia cuando la participación en el proceso penal genere riesgo real, grave o extraordinario. Está dirigido a víctimas de violencias sexuales vinculadas al proceso, testigos con información relevante y personas cercanas cuya integridad pueda verse comprometida, aspectos que se desarrollan a continuación:

- **Marco normativo**
  - Constitución Política de Colombia.
  - Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal).
  - Ley 1257 de 2008.
  - Reglamentos internos de la Fiscalía General de la Nación.
- **Finalidad**
  - Proteger frente a amenazas derivadas del proceso penal.
  - Garantizar condiciones seguras para declarar.
  - Prevenir represalias.
  - Facilitar el acceso efectivo a la justicia.
- **Personas beneficiarias**
  - Víctimas de violencias sexuales vinculadas al proceso penal.
  - Testigos con información relevante para la investigación.
  - Personas cercanas cuya seguridad pueda verse comprometida.

11.2. Trámite especial de emergencia

El trámite especial de emergencia corresponde al conjunto de medidas inmediatas y excepcionales de protección que pueden activarse cuando una persona víctima de violencias sexuales enfrenta un riesgo inminente, grave o extraordinario para su vida, integridad o libertad, y no es posible esperar la aplicación de los procedimientos ordinarios de protección.

El trámite especial de emergencia se fundamenta en el principio de protección reforzada y en la obligación del Estado de actuar con debida diligencia para prevenir daños irreparables, conforme a la Constitución Política de Colombia (1991) y al Decreto 1066 de 2015 (Ministerio del Interior, 2015).

Con el fin de comprender el alcance y la operatividad del trámite especial de emergencia, es necesario identificar su finalidad, las características que lo distinguen de los procedimientos ordinarios y las situaciones que justifican su activación. Estos elementos permiten precisar su aplicación dentro del marco de protección reforzada y debida diligencia estatal:

Finalidad

- Prevenir la ocurrencia de un daño grave o irreparable.
- Garantizar condiciones mínimas de seguridad inmediata.
- Facilitar la transición hacia mecanismos de protección permanentes.
- Proteger a la víctima sin exigir requisitos formales previos.

Características principales

- Activación inmediata y prioritaria.
- No requerir denuncia penal previa.
- Adoptar medidas de carácter temporal y urgente.
- Aplicarse con enfoque diferencial y de derechos.
- Exigir articulación intersectorial obligatoria.

Situaciones que justifican su activación

- Amenazas directas o creíbles contra la víctima.
- Riesgo de reiteración de la violencia.
- Contextos de violencia sociopolítica o de control territorial.
- Situaciones que evidencien peligro inminente para la vida o integridad.

12. Restablecimiento de derechos y seguimiento

El restablecimiento de derechos constituye un proceso administrativo integral orientado a garantizar la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias sexuales. Este proceso busca cesar la vulneración, prevenir su repetición y asegurar el ejercicio pleno de los derechos afectados, mediante acciones coordinadas entre las entidades competentes. Su desarrollo exige articulación intersectorial y actuación con debida diligencia reforzada por parte del Estado.

Para comprender su aplicación y alcance, es necesario precisar el concepto de restablecimiento de derechos, así como sus características esenciales dentro del marco de protección integral:

Concepto de restablecimiento de derechos

El restablecimiento de derechos se define como el conjunto de decisiones administrativas, acciones intersectoriales y medidas de protección orientadas a cesar la vulneración, prevenir su repetición y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados por violencias sexuales.

Este proceso se caracteriza por:

- No tener naturaleza sancionatoria.
- No depender de la denuncia penal.
- No agotarse en una sola actuación.
- Mantenerse mientras persista la situación de riesgo o vulneración.

Además, implica una evaluación integral de las condiciones del niño, niña o adolescente, que incluye su entorno familiar, social, educativo y comunitario, así como

la identificación de factores de riesgo y de protección que orienten la adopción de medidas adecuadas.

La competencia para adelantar este proceso recae en las autoridades administrativas definidas por la normativa vigente.

12.1. Autoridades competentes

El proceso de restablecimiento de derechos es competencia exclusiva de las autoridades administrativas de protección, conforme a lo establecido en la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia). Estas autoridades tienen la responsabilidad de iniciar, dirigir y garantizar las medidas necesarias para proteger y restituir los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes. A continuación, se presentan las entidades competentes encargadas de su implementación:

- Defensorías de Familia del ICBF
- Comisarías de Familia
- Inspectores de Policía (en ausencia de las anteriores)
- Autoridades indígenas

Estas autoridades tienen la facultad de iniciar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, adoptar las medidas de protección necesarias, realizar seguimiento y modificar dichas medidas cuando las circunstancias lo requieran, así como coordinar acciones con los sectores de salud, educación, justicia y protección social para garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

- **Medidas administrativas de restablecimiento de derechos**

Las medidas administrativas de restablecimiento de derechos son decisiones adoptadas por la autoridad competente con el fin de proteger al NNA y garantizar su bienestar integral, atendiendo al nivel de riesgo identificado.

Principales medidas

- Ubicación en medio familiar protector.
- Separación temporal del agresor.
- Ubicación en hogar sustituto o institución de protección.
- Garantía de atención integral en salud física y mental.
- Acceso y permanencia en el sistema educativo.
- Acompañamiento psicosocial individual y familiar.
- Seguimiento periódico del caso.

12.2. Seguimiento intersectorial

El seguimiento intersectorial constituye un proceso continuo y coordinado orientado a verificar la efectividad de las medidas adoptadas y garantizar la continuidad de la atención integral. Se fundamenta en los principios de corresponsabilidad institucional, enfoque de derechos, confidencialidad y no revictimización.

Uno de sus componentes centrales es la verificación de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes. En este marco, el seguimiento permite verificar la vigencia y eficacia de las medidas de protección, identificar riesgos nuevos o persistentes, evaluar la necesidad de ajustes o fortalecimiento de las medidas, articular acciones con las autoridades responsables de justicia y protección, y realizar el registro sistemático de la evolución del caso.

El seguimiento intersectorial implica verificar el cumplimiento de las responsabilidades institucionales y asegurar la continuidad del acompañamiento para evitar nuevas vulneraciones:

- **Verificación del cumplimiento interinstitucional**

Este proceso busca asegurar que cada entidad cumpla con las responsabilidades asignadas dentro de la ruta de atención.

Elementos de verificación

  - Cumplimiento de las remisiones realizadas.
  - Acceso efectivo a los servicios asignados.
  - Coordinación oportuna entre sectores.
  - Identificación de fallas o vacíos en la atención.
  - Activación de acciones correctivas cuando sea necesario.

A continuación, se presentan los elementos que garantizan la efectividad del seguimiento intersectorial, mediante la continuidad del acompañamiento institucional a la víctima y la articulación permanente entre las entidades responsables:

- **Continuidad del acompañamiento intersectorial**
  - Mantener apoyo institucional permanente.
  - Evitar cierres prematuros del proceso.
  - Prevenir desarticulaciones entre entidades.
  - Garantizar atención integral sostenida.
- **Componentes del acompañamiento continuo**
  - Seguimiento clínico y en salud mental.
  - Acompañamiento psicosocial.

- Articulación con programas de protección.
- Apoyo en el acceso a servicios sociales y educativos.
- Orientación permanente en derechos.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de los principales contenidos desarrollados en este proceso formativo, organizados en ejes fundamentales de la respuesta institucional: la articulación entre sectores, la activación de rutas de atención, el acceso a la justicia, la aplicación de medidas de protección y el seguimiento para el restablecimiento de derechos. Estos elementos orientan la coordinación entre las entidades responsables y fortalecen las acciones administrativas, legales y operativas necesarias para brindar una atención integral. De esta manera, se promueve una actuación oportuna, ética y articulada que contribuya a proteger la vida, la dignidad y los derechos de las personas afectadas por violencias sexuales.

Glosario

Atención intersectorial: proceso de coordinación simultánea entre los sectores de salud, justicia, protección y apoyo social, con el fin de garantizar una respuesta integral y efectiva frente a las violencias sexuales.

Cadena de custodia: conjunto de procedimientos que garantizan la integridad, autenticidad y trazabilidad de los elementos materiales probatorios desde su recolección hasta su análisis final por la autoridad competente.

Consentimiento informado: proceso mediante el cual la persona recibe información clara, suficiente y comprensible sobre las intervenciones en salud y expresa voluntariamente su aceptación, sin coacción ni presión, respetando su autonomía y dignidad.

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): procedimiento de carácter legal mediante el cual se interrumpe un embarazo en los casos permitidos por la normatividad vigente, incluyendo aquellos derivados de violencia sexual, garantizando atención segura y sin barreras.

Interés superior del niño, niña y adolescente: principio rector que establece que toda decisión que afecte a un niño, niña o adolescente debe priorizar su protección, bienestar y desarrollo integral por encima de cualquier otro interés.

Notificación obligatoria: reporte que debe realizar el sector salud a los sistemas de vigilancia en salud pública sobre eventos de interés, como las violencias sexuales, con fines epidemiológicos y de salud pública.

Primeros auxilios psicológicos (PAP): intervención inicial y breve orientada a brindar apoyo emocional inmediato, reducir el impacto del evento traumático y fortalecer la capacidad de afrontamiento de la persona víctima.

Profilaxis posexposición (PEP): conjunto de tratamientos farmacológicos administrados de manera oportuna para reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, tras una exposición de riesgo.

Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS): sistema de información que consolida los datos de los servicios de salud prestados, permitiendo la trazabilidad administrativa, el seguimiento institucional y la facturación.

Restablecimiento de derechos: proceso orientado a garantizar que las personas víctimas recuperen el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, mediante acciones articuladas entre los sectores de salud, protección, justicia y asistencia social.

Ruta de atención: conjunto de procedimientos, mecanismos y acciones articuladas entre diferentes instituciones que permiten garantizar la atención integral, la protección y el restablecimiento de derechos de las personas víctimas de violencias sexuales.

Seguimiento clínico: proceso de control y evaluación periódica del estado de salud físico y mental de la víctima, orientado a garantizar la continuidad de la atención y la detección temprana de complicaciones.

Referencias bibliográficas

Congreso de la República de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia. https://www.constitucioncolombia.com

Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.

Congreso de la República de Colombia. (2007). Ley 1146 de 2007. Por medio de la cual se dictan normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.

Congreso de la República de Colombia. (2008). Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

Corte Constitucional de Colombia. (2006). Sentencia C-355 de 2006.

Corte Constitucional de Colombia. (2022). Sentencia C-055 de 2022.

Instituto Nacional de Salud. (s. f.). Lineamientos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2012). Protocolo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Lineamientos técnicos para la atención integral de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Presidencia de la República de Colombia. (2015). Decreto 1069 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales (RED)	Dirección General
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Liliana M. Támara P.	Experta temática	Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Regional Distrito Capital
Osana Medina Bonilla	Experta temática	Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Regional Distrito Capital
Juan Camilo González	Asesor pedagógico	Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Regional Distrito Capital
María Helena Tamayo	Asesora pedagógica	Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Regional Distrito Capital
Laura Briguitte Perea Possos	Experto temático	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Gloria Lida Alzate Suárez	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Juan Daniel Polanco Muñoz	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Manuel Felipe Echavarria Orozco	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Ernesto Navarro Jaimes	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
María Fernanda Pineda Mora	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculador de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima